



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض رباعياً : رباب احمد علي احمد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الزاوية الحمراء
العنوان : الزاوية
رقم البطاقة : 27903250104709 رقم التليفون : 01155745074
تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 25-03-1979 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدة 6 شهور
قسم العلاج :
الأورام
[14163]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رباب احمد علي احمد National ID: 27903250104709	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٤/١٢ ٢٧٩٠٣٢٥٠١٠٤٧٠٩
حاصله على نيلوم تجاره
متروجة مسلمة انش
عصام محمد عبدالسلام محمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١٢/٠١



رباب
احمد على احمد ارنب
٧٣ ش سيد الحنطوى من ش فوزى
المرج - القاهرة



٢٧٩٠٣٢٥٠١٠٤٧٠٩

KW3288694



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : رانيا أحمد علي أحمد

Sex:

3- Medical number:

Female

83195520

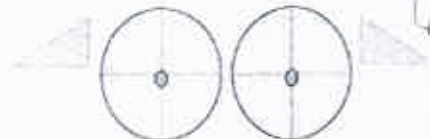
Old Med :

Old Med :

891-2024

2-ID number:

Patient Age : 46 Y



Family history

Family history
+ve

Phone

Phone

01282865250

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST OPERATIVE

marital status

Marital status
+ve

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

2025-01-29

Co morbidity

Co morbidity
appendectomy

Menopausal
status

Menopausal status
+ve

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

mri breast :lt breast UIQ mass with mass enhancement 5 cm multiple sr
satellites+path axillary LN

Mets Workup :

cy cap: osseous lesion

BX
ILC

BX COMMENT

ER
8/8

ER COMMENT

PR
7/8

PR COMMENT

Her 2 Neu
3

Her 2 Neu COMMENT

SISH

SISH COMMENT

Ki67

T
3

N
1

M
0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

pt received TCHP x 6 cycles with good response last 6/11/2024

LT MRM : free margins

LN 0/30

complete pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

FOR HERCEPTIN SC FOR 1 YEAR, PORT, AI ZOLADEX FOR 5 YEARS CONSIDER EXTENDED

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition

Name: رباب احمد علي احمد		
MR. : 5638		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient presented for administration of Zoladex 10.8 mg and Arimidex, with supplemental therapy noted as "tt fior 3 mn BSM < PAUS >>> R." No additional complaints or concerns were documented at this visit. The patient reported no specific complaints. Imaging performed on 16 May 2026 included a sonomammography reported as BIRADS 1 and a pelvic/abdominal ultrasound performed in April 2026, both of which were unremarkable. The patient was deemed free to continue Arimidex and Zoladex therapy.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	Reham Ahmed Fathy Ibrahim الطبيب المعالج :	
يعتمد ,		

Patient Name	: الأستاذة / رباب أحمد علي أحمد	Request No.	: 13006218
Patient No.	: 27903250104709	Request Date	: 23/03/2024
Path No.	: SR-382/24	Verification Date	: 01/04/2024
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer.
Nature of Specimen: Slide Revision

Gross Examination:

- One paraffin block labeled by (200296/24) and three slides were received.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive lobular carcinoma
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:

Left breast mass, Slide Revision;
Invasive lobular carcinoma, Grade II,
IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).
- Her2: Positive (score 3+).

Signature
Dr. Rana Fathy
Dr. Heba Hasan

Verified by :
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 07/05/2024 12:43:13

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss





Patient Name : الأستاذ / رباب احمد على احمد
Patient No. : 27903250104709
Path No. : 5109/24
Sex : Female
Age : 45 Y
Refferreing Doc :
Request No. : 13007259
Request Date : 21/12/2024
Verification Date : 12/01/2025
Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

83195520
رباب احمد على احمد
المرضى
رقم الملف
35/23228
27903250104709
891/2024
HCE NO

Clinical Data: Left breast cancer post NACT .
Nature of the specimen: Left breast & Left axilla (MRM)

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM
measured 27x22x6 cm with covering skin ellipse measured 23x17 cm .
- Localization: UOQ
- Tumor extent : A greyish white tumour bed site
- Size: 6 x5 x3 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 2 cm away from deep margin , 1 cm away from the skin .
- Axilla fibrofatty tissue piece revealed 30 nodules up to 3x1.5
- Microscopic examination:
- Histological type: No residual tumor
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free L.Ns (0/30)
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:

Left MRM (post NACT) :

Total tumor regression

- Free margins
- Free nipple and areola
- Free L.Ns (0/30)
- Pathologic complete response

Verified by :

Printing Date : 15/01/2025 11:01:46

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Patient Name	: الأستاذة / رباب احمد على احمد	Request No.	: 13007259
Patient No.	: 27903250104709	Request Date	: 21/12/2024
Path No.	: 5109/24	Verification Date	: 12/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: marwa mohamed yous

Pathology Report

▪ Stage : ypT0 , ypN0

Signature
Prof. Dr. Amal Ha
Dr.Heba Hassan

Verified by :



PATIENT NAME: RABAB AHMED ALI AHMED

GENDER: Female

DATE : 18-Feb-2024 10:19 AM

PATIENT ID: 20224006241

AGE: 44 y

ORDER: 259010 259029

Clinical Indication - all studies

Report: - all studies

**FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND****INDICATION:**

- Left palpable mass since one year.

REPORT:

- Bilateral Scattered fibroglandular densities (ACR b).
- **Left breast :**
- Ill defined UOQ and Upper central parenchymal distortion mounting to mass formation with grouped calcifications.
- Complementary US confirmed the presence of a palpable large non circumscribed heterogenous hypoechoic altered parenchyma mounting to mass formation casting posterior shadowing, it measures about 46x21mm with no vascular signal detected upon Color Doppler application. Another similar smaller lesion is noted about 5-6cm far from nipple, 11mm deep to skin noted more lateral to index mass at 2.00 zone C with unhealthy intervening parenchyma between both lesions. Retroareolar prominent duct reaching 2mm with no internal contents. 5.00 thick walled cyst with moving internal debris is seen measuring 19x5mm.
- Ipsilateral at least two small sized pathological axillary LN measuring 8x7mm with cortical thickness 4mm and another one with muffled hilum measuring 9x5mm.
- Prominent level one infraclavicular LN.
- No supraclavicular or internal mammary LN noted at time of scan.
- **Right breast :**
- No spiculated mass lesions or grouped microcalcifications.
- Complementary Ultrasound showed multiple scatted minute cysts with no internal debris and dilated retroareolar ductal caliber reaching 6mm

PATIENT: RABAB AHMED ALI AHMED, 20224006241, Female, 44 y

Report version 1.

Page 1 of 2



www.Bohiya.org



16602

RABAB AHMED ALI AHMED

20224006241

259010 259029

18-Feb-2024

10:19 AM

10:19 AM

- with no internal inspissated sections. No solid mass lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes
- Nonspecific axillary lymphadenopathy.

OPINION:

- Left sided pathologically proven IDC (outside Baheya) with ipsilateral Pathological axillary LN as described. (BIRADS6)
- Right sided fibrocystic disease and dilated ducts.

Recommendation - all studies

Referral to clinic

Reported By,

Dr. Rehab El sheikh, MD

18-Feb-2024 11:27 AM

PATIENT: RASAB AHMED ALI AHMED, 20224006241, Female, 44 y

Report version 1.

Page 2 of 2



www.Baheya.org



16602

مركز باهية الجوامع
والعلاج الطبي في شرم الشيخ
مستشفى باهية الجوامع
والعلاج الطبي في شرم الشيخ



PATIENT NAME: RABAB AHMED ALI AHMED
 GENDER: Female
 DATE: 18-Mar-2024 12:54 PM

PATIENT ID: 20224006241
 AGE: 44 y
 ORDER: 2770657,2770685

Report: - all studies

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

1-CHEST

Pathologically proven left breast ILC:

- Left breast 12 o'clock and UIQ ill defined parenchymal area mounting to mass formation measuring about 4.5 X 5cm with overlying mild skin thickening.
- Multiple prominent left level I, II axillary lymph nodes the largest measures 13 X 9 mm.
- Few bilateral tiny fissural based millimetric nodules likely insignificant.
- Right lower lung lobe minimal pleural thickenings.
- Otherwise, No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers.
- No pericardial effusion detected.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is mildly enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation (on non contrast basis).
- Normal appearance of the pancreas, spleen, kidneys, adrenals, aorta, I. V.C and the pelvic organs.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bilateral adnexal small cystic lesions the largest is on the right side measuring about 32mm in diameter for local US assessment.
- No sizable pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

PATIENT: RABAB AHMED ALI AHMED, 20224006241, Female, 44 y
 Report version 2, 19-Mar-2024 03:04 PM



Name: Rabab Ahmed Ali

Date: 28/4/2024

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information: *skeletal surveying to detect multiple lesions.*

Technique: Anterior and posterior whole-body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP.

Report:

- Heterogenous tracer uptake is noted at Dorso-lumbar vertebrae likely degenerative changes.
- No definite hot spot that accounts for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

No scintigraphic evidence of active osseous lesions could be seen at the surveyed body.

Thanks for referral

Nuclear Medicine Unit

DR. Sherin Mahdy, MD

DR/ Mohamed Emam